

DISTHYROX

- **Dạng thuốc:** Viên nén.
- **Quy cách đóng gói:** Hộp 5 vỉ x 20 viên. Kèm theo tờ hướng dẫn sử dụng thuốc.
- **Công thức bào chế cho 1 đơn vị (1 viên):** thành phẩm: Mỗi viên nén chứa:
Levothyroxin natri.....100mcg
Tá dược vđ.....1 viên

(Tá dược gồm: Microcrystallin cellulose, natri starch glycolat, copovidon, magnesi stearat, crosopovidon).

- **Dược lực:** Levothyrox là dạng tổng hợp của hormon chủ yếu của tuyến giáp Thyroxin (T4). Hormon tuyến giáp làm gia tăng tốc độ chuyển hóa của tế bào tất cả các mô của cơ thể. Ở bào thai và trẻ sơ sinh, hormon tuyến giáp quan trọng cho sự tăng trưởng và phát triển của tất cả các mô kể cả xương và não. Ở người lớn, ngoài một số tác động, hormon tuyến giáp còn giúp duy trì chức năng não, chuyển hóa thức ăn và nhiệt độ cơ thể.

- **Dược động học:**
Mặc dù được sinh tổng hợp nhưng Levothyroxin rất giống L-thyroxin từ tuyến giáp; trung bình 80% được hấp thu từ đầu ruột non ở cả người có tuyến giáp bình thường lẫn người thiếu năng tuyến giáp.

Nồng độ đỉnh huyết thanh T4 từ 2 đến 4 giờ sau khi uống Levothyroxin. Hơn 99,9% T4 gắn với protein vận chuyển (TBG, transthyretin, albumin). Levothyroxin và T4 nội sinh giống nhau về thời gian bán thải sinh học (168 giờ), trong khi tốc độ thay thế là 10% và thể tích phân bố là khoảng 10l. Một nửa Levothyroxin được phân bố trong huyết thanh và các mô ngoại bào, một phần tư trong gan và trong thận, một phần tư còn lại trong các mô khác (cơ, mô mỡ, da và hệ thần kinh).

Levothyroxin thải trừ chậm khỏi cơ thể, thời gian bán thải trung bình là 7 ngày. Tuy nhiên, thời gian bán thải được rút ngắn khi chuyển hóa gia tăng, như trong bệnh cường giáp, và kéo dài thêm khi ngược lại, chức năng cơ thể chậm hơn, như trong thiếu năng giáp.

- **Chỉ định:**
Dùng điều trị thay thế cho các trường hợp thiếu hormon giáp trạng (thiếu năng tuyến giáp).

Ngăn ngừa sự phì đại trở lại của tuyến giáp sau khi cắt bướu trong các trường hợp chức năng tuyến giáp bình thường.

Điều trị bướu giáp lành tính trong các trường hợp chức năng tuyến giáp bình thường.

Điều trị kết hợp trong các điều trị cường giáp với các thuốc kháng giáp sau khi đạt được tình trạng tuyến giáp bình thường.

Liệu pháp điều trị và thay thế trong các trường hợp bướu giáp ác tính sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp.

Xét nghiệm ức chế tuyến giáp.

- **Cách dùng và liều dùng:**

Cách dùng: Liều hàng ngày được uống bằng cách nuốt toàn bộ viên thuốc với một lượng nước nhỏ vào buổi sáng, khi dạ dày rỗng, ít nhất là ½ giờ trước khi ăn sáng.

Trẻ em uống thuốc ít nhất là ½ giờ trước bữa ăn đầu tiên trong ngày. Ngâm viên thuốc với một chút nước cho thuốc tan ra và trở thành hỗn dịch mịn (chỉ nên thực hiện cho mỗi lần uống), sau đó cho trẻ uống thêm một ít nước.

Liều dùng: *Người lớn:

Chỉ định	Liều dùng (mcg/ngày)
Suy giáp: (tăng 25-50mcg cho mỗi 2-4 tuần điều trị)	Liều khởi đầu: 25-50 mcg Liều tiếp theo: 100- 200mcg
Ngăn ngừa sự phì đại trở lại của tuyến giáp sau phẫu thuật cắt bỏ tuyến giáp	75- 200mcg
Điều trị bướu giáp lành tính trong các trường hợp chức năng tuyến giáp bình thường	75- 200mcg
Điều trị kết hợp trong điều trị cường giáp với các thuốc kháng giáp	50-100mcg
Các trường hợp bướu giáp ác tính sau phẫu thuật tuyến giáp	150-300mcg
Xét nghiệm ức chế tuyến giáp khi xạ hình tuyến giáp	200mcg/ngày (14 ngày sau khi xạ hình tuyến giáp).

***Trẻ em:** Dùng liều khởi đầu tối đa là ½ viên (tương đương với 50 mcg) mỗi ngày. Trong những trường hợp điều trị lâu dài, liều dùng phụ thuộc vào nhiều yếu tố như tuổi và cân nặng của trẻ.

Bảng hướng dẫn liều dùng ở trẻ em:

Tuổi	Liều (mcg/ngày)	Liều (mcg/kg/ngày)
0-6 tháng	25-50	10-15
6-24 tháng	50-75	8-10
2-10 tuổi	75-125	4-6
10-16 tuổi	100-200	3-4
> 16 tuổi	100-200	2-3

(Thuốc này chỉ dùng theo kê đơn của bác sĩ)

- **Chống chỉ định:**

Trẻ em không nuốt được viên nén.

Cường giáp trừ những người đang điều trị với chất kháng giáp trạng tổng hợp. Nhìn chung không khuyến cáo sử dụng thuốc này cho những bệnh nhân bị bệnh tim mất bù, bệnh động mạch vành hoặc rối loạn nhịp tim không kiểm soát được.

- **Thận trọng:**

Theo dõi chặt chẽ trong trường hợp rối loạn mạch vành hay rối loạn nhịp tim. Thận trọng khi dùng trong trường hợp: cao huyết áp, suy vô thượng thận, tình trạng chân ăn kèm suy dinh dưỡng, bệnh lao. Ở bệnh nhân tiểu đường, do hormon tuyến giáp làm tăng đường huyết, nên cần phải tăng liều thuốc hạ đường huyết. Trong trường hợp có tiểu sử bệnh tim mạch, phải cho đo điện tâm đồ.

- **Phụ nữ có thai và nuôi con bú:**

Các hormon tuyến giáp không dễ qua hàng rào nhau thai. Chưa thấy tác dụng nào đến bào thai khi người mẹ mang thai dùng hormon giáp. Việc điều trị vẫn được tiếp tục cho người phụ nữ thiếu năng tuyến giáp vì trong thời kỳ mang thai, nhu cầu levothyroxin có thể tăng. Cần điều chỉnh liều bằng cách kiểm tra định kỳ nồng độ TSH trong huyết thanh.

Một lượng nhỏ hormon tuyến giáp được bài tiết qua sữa. Thuốc không gây tác dụng có hại đến trẻ nhỏ và không ảnh hưởng lên hệ thần kinh.

- **Tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy móc:** Không dùng thuốc khi lái xe và vận hành máy móc vì tác dụng phụ của thuốc gây kích động, nhịp tim nhanh, mất ngủ là những ảnh hưởng lên hệ thần kinh.

- **Tác dụng không mong muốn:** Làm nặng thêm bệnh lý tim (đau thắt lồng ngực, nhồi máu cơ tim, rối loạn nhịp tim ...).

Dấu hiệu cường giáp: Nhịp tim nhanh, mất ngủ, kích động, nhức đầu, sốt, vã mồ hôi, gầy nhanh, tiêu chảy; khi xuất hiện các dấu hiệu này phải ngưng điều trị vài ngày trước khi bắt đầu lại với liều thấp hơn. Có khả năng tăng Canxi niệu ở trẻ còn bú và trẻ em.

*** Ghi chú: "Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc".**

- **Tương tác thuốc:**

Thuốc chống đông máu: Hormon tuyến giáp làm tăng tác dụng thuốc chống đông máu.

Thuốc tiểu đường: Hormon tuyến giáp làm giảm hiệu lực của thuốc trị tiểu đường.

Sự phối hợp với các thuốc chống trầm cảm 3 vòng sẽ làm tăng tác dụng qua lại lẫn nhau.

Colestyramin: Làm giảm hiệu lực của hormon tuyến giáp.

Các thuốc gây cảm ứng men: làm tăng chuyển hóa của T3 và T4.

- **Quá liều và xử trí:**

*** Triệu chứng:** Gây trạng thái tăng chuyển hóa tương tự như nhiễm độc giáp nội sinh. Dấu hiệu và triệu chứng như sau: Giảm cân, tăng thêm ăn, đánh trống ngực, bồn chồn, ỉa chảy, co cứng bụng, vã mồ hôi, nhịp tăng nhanh, tăng huyết áp, loạn nhịp, giật rung, mất ngủ, sợ nóng, sốt, rối loạn kinh nguyệt. Triệu chứng không phải lúc nào cũng lộ rõ, có thể nhiều ngày sau khi uống thuốc mới xuất hiện.

*** Xử trí:** Levothyroxin cần được giảm liều hoặc ngừng tạm thời nếu dấu hiệu và triệu chứng quá liều xuất hiện. Quá liều cấp, phải điều trị triệu chứng và hỗ trợ ngay. Mục đích điều trị là làm giảm hấp thu ở đường tiêu hóa và chống tác dụng trên thần kinh trung ương và ngoại vi chủ yếu là những tác dụng tăng hoạt động giao cảm. Có thể rửa dạ dày ngay hoặc gây nôn nếu không có chống chỉ định khác (hôn mê, co giật, mất phân xạ nôn). Cholestyramin hoặc than hoạt cũng được dùng để giảm hấp thu levothyroxin. Cho thở oxy và duy trì thông khí nếu cần. Dùng các chất chẹn beta - adrenergic ví dụ propranolol để chống nhiều tác dụng tăng hoạt động giao cảm. Tiêm tĩnh mạch propranolol 1 - 3 mg/10 phút hoặc uống 80 - 160 mg/ngày đặc biệt là khi không có chống chỉ định. Có thể dùng các glycosid trợ tim nếu suy tim sung huyết xuất hiện. Cần tiến hành các biện pháp kiểm soát sốt, hạ đường huyết, mất nước khi cần. Nên dùng glucocorticoid để ức chế chuyển hóa từ T₄ thành T₃. Do T₄ liên kết protein nhiều nên rất ít thuốc được loại ra bằng thẩm phân.

- **Hạn dùng:** 24 tháng tính từ ngày sản xuất. *Không dùng thuốc đã quá hạn sử dụng.* Khi thấy viên thuốc bị ẩm mốc, biến màu, nhân thuốc in số lỗ SX, HD mờ...hay có các biểu hiện nghi ngờ khác phải đem thuốc tới hội lợi nơi bán hoặc nơi sản xuất theo địa chỉ trong đơn.

- **Bảo quản:** Nơi khô, nhiệt độ dưới 30°C.

- **Tiêu chuẩn áp dụng:** ĐDVN V

ĐỂ XA TẮM TAY TRẺ EM

**"Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
Nếu cần thêm thông tin xin hỏi ý kiến bác sĩ"**

THUỐC SẢN XUẤT TẠI:
CÔNG TY C.P DƯỢC PHẨM HÀ TÂY
La Khê - Hà Đông - TP. Hà Nội
ĐT: 04 33 824685 FAX: 04 33 829054